

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Unidad de Postgrado

Facultad de Ciencias Sociales



Proyecto de Tesis

MAESTRÍA EN POLÍTICA SOCIAL CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

**Título: Percepción de los usuarios sobre la atención comunitaria en la
etapa de ingreso y diagnóstico en el Centro de Salud Mental Comunitario
Universitario San Marcos. Periodo 2025**

Alumno: Pedro Augusto Medina Gonzales

Código: 23157080

Correo: pedro.medina@unmsm.edu.pe

LIMA, PERÚ

Agosto 2025

ÍNDICE

I.	Planteamiento del problema	3
II.	Justificación de la Investigación.....	3
III.	Preguntas de Investigación.....	4
IV.	Objetivo General y específicos.....	4
V.	Estado del Arte.....	5
VI.	Marco Teórico.....	6
VII.	Hipótesis.....	10
VIII.	Metodología y técnicas de investigación.....	10
IX.	Universo y población de estudio.....	13
X.	Criterios de Inclusión e Exclusión.....	15
XI.	Cronograma.....	16
XII.	Bibliografía.....	17
XIII.	ANEXOS.....	21
XIV.	Matriz de Consistencia.....	28

I. Planteamiento del problema

El acceso limitado a los servicios de salud mental en el Perú constituye un problema crítico que afecta el bienestar de la población, generando consecuencias como depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, estrés laboral, violencia y altos índices de suicidio. A pesar de contar con políticas nacionales, planes estratégicos y proyectos enfocados en la atención de la salud mental, la población más vulnerable enfrenta barreras significativas para acceder y mantener constancia en estos servicios.

Esta problemática afecta particularmente a los estudiantes universitarios, un grupo que, debido a factores económicos y etarios, enfrenta mayores limitaciones para acceder de manera eficiente a los servicios de salud mental. Durante la etapa universitaria, los jóvenes están especialmente expuestos a desarrollar trastornos como la depresión y la ansiedad, lo que resalta la importancia de estudiar sus experiencias al acceder a los servicios disponibles.

La presente investigación se desarrolla en el Centro de Salud Mental Comunitario Universitario San Marcos (CSMCU), ubicado en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como un caso representativo. Se busca analizar cómo los estudiantes enfrentan el proceso de atención, identificando las barreras de acceso y los desafíos presentes en la etapa inicial de atención que podrían limitar la efectividad de este servicio esencial.

II. Justificación de la investigación

La salud mental se ha convertido en una prioridad dentro de la vida universitaria, debido al incremento de ansiedad, estrés y otras dificultades emocionales que afectan el bienestar y rendimiento académico de los estudiantes. En este contexto, el Centro de Salud Mental Comunitario Universitario San Marcos (CSMCU) cumple un rol esencial al brindar atención especializada y gratuita a la comunidad estudiantil.

Sin embargo, se conoce poco sobre cómo los estudiantes viven el proceso de atención, especialmente en la etapa inicial de ingreso y diagnóstico, donde pueden surgir barreras, expectativas no atendidas o dificultades de acceso. De igual modo, el personal del centro enfrenta limitaciones institucionales y desafíos cotidianos que influyen en la calidad y oportunidad de la atención.

Esta investigación busca comprender ese proceso desde ambas perspectivas: las experiencias de los estudiantes y las percepciones del personal de salud. Analizar la etapa de ingreso y diagnóstico permitirá identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora que contribuyan a fortalecer la accesibilidad, la pertinencia y la calidez del servicio.

La pertinencia de esta investigación se sustenta en su relación directa con la Política Social y la Gestión de Proyectos Sociales, al analizar un servicio público que forma parte de la red estatal de atención en salud mental. Estudiar el proceso de ingreso y diagnóstico en el CSMCU permite observar cómo las orientaciones del Estado - marcadas por la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030, la Ley de Salud Mental N° 30947 y el Modelo de Atención Comunitaria- se traducen en prácticas concretas dentro de una institución universitaria.

En conjunto, el estudio aporta evidencia útil para mejorar la implementación de políticas, optimizar servicios sociales y fortalecer la gestión institucional en salud mental, contribuyendo al bienestar integral de la comunidad universitaria.

III. Preguntas de investigación

Las preguntas de investigación guiarán el proceso de recolección y análisis de datos. Las preguntas generales y específicas son las siguientes:

- **Pregunta general:**
 - ¿Cómo vivencian los estudiantes y el personal de salud del CSMCU el proceso de ingreso y diagnóstico, y qué factores influyen en su desarrollo?
- **Preguntas específicas:**
 - ¿Qué experiencias, barreras y expectativas expresan los estudiantes respecto a su proceso de ingreso y diagnóstico en el CSMCU?
 - ¿Qué limitaciones institucionales y operativas que afectan el desarrollo de la atención inicial identifica el personal de Salud?
 - ¿Qué puntos en común y qué diferencias surgen entre las percepciones de estudiantes y personal de salud sobre la calidad, accesibilidad y organización del proceso de atención inicial?

IV. Objetivo general y específicos

- **Objetivo General:**

- Analizar el proceso de ingreso y diagnóstico en el CSMCU San Marcos desde las percepciones de estudiantes y personal de salud, identificando los factores que influyen en la experiencia de atención inicial
- **Objetivos específicos:**
 - Describir las experiencias, barreras y expectativas percibidas por los estudiantes durante el proceso de ingreso y diagnóstico en el CSMCU San Marcos.
 - Identificar las limitaciones institucionales y operativas vinculadas a la atención inicial de los estudiantes.
 - Comparar y triangular las percepciones de ambos actores para reconocer coincidencias, diferencias y oportunidades de mejora en el proceso de atención inicial.

V. Estado del Arte

La atención psiquiátrica ha atravesado importantes transformaciones históricas. En sus inicios, se basaba en el modelo manicomial, donde los pacientes eran percibidos bajo estereotipos, según Goffman (2004). Este modelo surgió en el siglo XVII con la construcción de manicomios, posteriormente denominados asilos para in-sanos y, finalmente, hospitales psiquiátricos. Sin embargo, este enfoque se encuentra desactualizado por no alinearse con el respeto a los derechos humanos, dando paso a un modelo comunitario de atención en salud mental.

La Defensoría del Pueblo (2018) señala que el modelo comunitario promueve la integración de las personas con problemas de salud mental a su entorno mediante redes locales, familiares y sociales. Este enfoque de derechos y participación comunitaria prioriza la interacción activa del paciente con su comunidad para lograr una rehabilitación integral. Del Cueto (2014) destaca que analizar al paciente en su contexto social fortalece su conexión con su entorno y fomenta respuestas efectivas ante sus necesidades.

Durante la pandemia por COVID-19 (2020-2022), se incrementaron los desafíos en la atención de salud mental. Según Cusihuaman-Lope et al. (2023), el uso de tecnologías facilitó un soporte emocional, pero también se enfrentaron barreras como la falta de información uniforme y la disminución en la calidad de atención, atribuida a la virtualidad y la carencia de espacios privados adecuados.

Diversos estudios resaltan la importancia de la relación paciente-profesional. Cárcamo et al. (2019) identifican que un trato humanitario favorece la recuperación de personas con diagnósticos graves, mientras que Storm y Edwards (2013) destacan que la toma de decisiones compartidas aumenta la percepción de satisfacción sin garantizar necesariamente mejores resultados clínicos.

El artículo de Saavedra y Uchofen-Herrera (2016) subraya la necesidad de atención centrada en la persona, considerando sus valores individuales, contexto social, participación activa y autonomía. Minoletti et al. (2015), por su parte, evidencian la disparidad en la percepción de calidad entre usuarios y personal de salud, destacando la falta de retroalimentación por canales efectivos.

En el contexto peruano, Villa-Palomino et al. (2024) analizan las limitaciones en la implementación de los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) y los obstáculos que enfrentan los usuarios, como la desconfianza hacia los servicios y una integración limitada con la comunidad. Según la ENDES (2022), el 32.3% de jóvenes entre 15 y 29 años reportaron problemas de salud mental, un dato alarmante reforzado por el proyecto WHO World Mental Health International College Student (WMH-ICS), que encontró una prevalencia anual del 31% en estudiantes universitarios (Aurebach, 2018).

Otros estudios destacan factores de riesgo en universitarios. Barrera-Herrera et al. (2019) describen cómo la falta de apoyo social, relaciones familiares disfuncionales y dificultades económicas contribuyen a problemas de salud mental. Asimismo, Arrieta, Díaz y González (2013) corroboran la influencia de estos factores en estudiantes colombianos.

Finalmente, la pandemia exacerbó las brechas en los servicios de salud mental en Perú. La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública (2021) documenta cómo los CSMC afrontaron déficits en recursos y protocolos, implementando medidas de emergencia como teleconsultas, aunque con limitaciones significativas en su ejecución.

VI. Marco Teórico

Es fundamental señalar que este trabajo se orientará desde un paradigma sociológico-comunitario, con una confluencia de enfoques teóricos que permitan abordar tanto los aspectos estructurales como los individuales y relacionales dentro de los procesos de salud y participación comunitaria.

1. Teoría Básica/General

El marxismo y los enfoques derivados de la teoría crítica proporcionan una visión estructural de la participación comunitaria. Según Sanabria (2004), el poder y la participación social son elementos claves para el desarrollo. Este enfoque se enmarca en un paradigma estructuralista, que considera las dinámicas de poder y las desigualdades sociales como puntos de partida para la acción transformadora. Este nivel de teoría es fundamental porque establece el contexto sociopolítico y estructural dentro del cual los fenómenos de salud y participación comunitaria ocurren.

VII. Teoría de Alcance Intermedio

En un nivel intermedio, Cruz y Aguilar (2002) y Molina (2000) contribuyen con enfoques más específicos sobre la interacción entre el individuo y su comunidad. Estos autores señalan que la participación comunitaria es un proceso continuo que involucra la identificación de problemas, la toma de decisiones y la implementación de soluciones, todo dentro de un marco de relaciones sociales que influyen el comportamiento individual y colectivo. Este enfoque permite analizar la participación comunitaria desde una perspectiva más práctica, aplicando teorías sociológicas a la realidad cotidiana de las personas en un contexto de salud.

VIII. Teoría para Fenómenos Inmediatos

A nivel inmediato, el Modelo Centrado en la Persona (Rango y Vega, 2015) y el Enfoque Intercultural (Henckell, 2022) ofrecen teorías aplicables directamente a la atención en salud, destacando la importancia de considerar al paciente como un sujeto activo dentro de su proceso de cuidado. La teoría del apoyo social (Fachado et al., 2012), con sus modelos de efecto directo y efecto tampón, se integra también en este nivel, ya que aborda cómo las relaciones sociales inmediatas impactan la salud mental y física de los individuos, especialmente en situaciones de estrés.

IX. Confluencia de Paradigmas

Este trabajo articula paradigmas estructuralistas, de participación social, y de atención centrada en la persona, permitiendo un análisis multifacético de los fenómenos observados. La interacción entre estos paradigmas nos permitirá comprender no solo las dinámicas estructurales y sociales que afectan la participación comunitaria y el acceso a la salud, sino también las experiencias individuales dentro de esos marcos, poniendo énfasis en las relaciones de poder, los contextos culturales y las necesidades emocionales de los pacientes.

Este enfoque de múltiples niveles de análisis garantiza una comprensión profunda y coherente de los fenómenos estudiados, permitiendo no solo una observación de los procesos inmediatos, sino también de los contextos y estructuras que los condicionan.

Uso de conceptos

En esta sección, se realiza un primer intento de vincular los conceptos clave desarrollados en el marco conceptual con los datos que se analizarán durante el trabajo de campo. A continuación, se expone cómo algunos de estos conceptos serán útiles para interpretar los resultados de la investigación:

1. **Calidad de atención:**
Este concepto será esencial para evaluar los servicios de salud mental en el CSMCU, analizando aspectos como eficacia, seguridad y enfoque centrado en la persona. Además, Donabedian (1984) identifica dos enfoques para evaluar la calidad: el desempeño de los profesionales y la evaluación de los sistemas de atención, considerando la equidad en la distribución de recursos.
2. **Modelo Asilar-Manicomial:**
Este concepto permitirá comparar el modelo tradicional de atención psiquiátrica, caracterizado por el aislamiento de los pacientes (Villa-Palomino, 2024), con enfoques más inclusivos. Según Sulca (2016), el modelo asilar excluía derechos fundamentales y aislaba al paciente de su entorno social, lo que contrasta con los principios del modelo comunitario.
3. **Modelo Comunitario de Salud Mental:**
Este enfoque prioriza la atención ambulatoria y fortalece la relación del paciente con su entorno (MINSA, 2016). Busca evitar el aislamiento y fomentar la participación activa de la comunidad en el proceso de atención. Asimismo, incluye servicios complementarios como programas de capacitación laboral y apoyo comunitario, orientados a mejorar la calidad de vida de las personas.
4. **Enfoque de derechos:**
Este enfoque evalúa el respeto a la dignidad, autonomía y participación de los estudiantes durante el proceso de atención. Según Carballada (2016), el enfoque de derechos articula leyes y responsabilidades para promover la integración social. Abramovich (2006) a través de la CEPAL añade que es un marco internacional que guía estrategias de desarrollo, promoviendo derechos humanos y sociales en la intervención.

5. **Participación social y comunitaria:**

Se entiende por comunidad un grupo humano que conviven en un mismo espacio geográfico, comparten rasgos culturales y un sistema de valores de manera homogénea. En esta comunidad los integrantes pueden compartir también problemas sociales, además de tener un sentido de pertenencia e identidad hacia su comunidad. La participación comunitaria implica la integración activa de la comunidad en la planificación y supervisión de los servicios de salud (Agudelo, 1983).

6. **Apoyo social:**

La OMS (2003) define el apoyo social como el soporte recibido de la red social de una persona, que puede incluir familia, amigos o personas cercanas. Thoits (1982) lo vincula con la satisfacción de necesidades sociales básicas como la afiliación y el afecto, mientras que Bowling (1991) lo considera un proceso dinámico de interacción que proporciona apoyo emocional, instrumental o económico. Este concepto investiga el papel de las redes de apoyo en la salud mental de los estudiantes. El análisis se centrará en cómo las interacciones sociales y los vínculos promovidos por el CSMCU impactan en el bienestar emocional de los usuarios.

7. **Salud mental/bienestar:**

Según la OMS (2020), la salud mental se define como un estado de bienestar en el que las personas pueden manejar el estrés, trabajar de manera productiva y contribuir a su comunidad. Este concepto permitirá evaluar la capacidad de los estudiantes para enfrentar desafíos emocionales, académicos y sociales.

8. **Cuidado integral de salud mental universitaria:**

Este enfoque se centra en estrategias holísticas que incluyen prevención, promoción, intervención temprana y rehabilitación (MINSA, 2016). Se explorará cómo el CSMCU implementa estas estrategias para atender las necesidades específicas de los estudiantes universitarios.

9. **Anomia:**

Durkheim (1893) define la anomia como una condición de desintegración social caracterizada por la ausencia o ambigüedad de normas y valores claros dentro de una sociedad. Este concepto, introducido en su estudio sobre el suicidio, describe un estado en el que los individuos se sienten desconectados y desorientados debido a la falta de normas sociales estables. Este concepto permitirá analizar cómo la desintegración social y la falta de apoyo estructural

dentro de la universidad pueden afectar el bienestar psicológico de los estudiantes, generando desconexión y desorientación.

10. Autocuidado:

Según Carballada (2016), el autocuidado es una herramienta de empoderamiento que permite a los individuos manejar su salud mental de manera independiente. En el contexto del CSMCU, se investigará cómo los programas promueven estas prácticas entre los estudiantes.

VII. Hipótesis

Para orientar nuestra investigación sobre la atención al usuario en la etapa de ingreso y diagnóstico de los usuarios universitarios del CSMCU San Marcos, formulamos las siguientes hipótesis que guiarán nuestro análisis:

- **Hipótesis general:**
 - Existen barreras percibidas por estudiantes y personal que afectan el proceso de ingreso y diagnóstico en el CSMCU.
- **Hipótesis específicas:**
 - Los estudiantes perciben barreras de acceso y claridad en el proceso.
 - El personal identifica limitaciones institucionales y operativas.
 - Las percepciones de estudiantes y personal muestran diferencias significativas.

VIII. Metodología y técnicas de investigación:

Enfoque metodológico

La presente investigación adopta un enfoque cualitativo, orientado a comprender en profundidad las percepciones, experiencias y significados que los actores atribuyen al proceso de ingreso y diagnóstico en el Centro de Salud Mental Comunitario Universitario San Marcos (CSMCU). Este enfoque permite analizar la atención desde la vivencia de los estudiantes y desde la perspectiva del personal de salud, reconociendo la subjetividad y las dinámicas institucionales como elementos fundamentales del fenómeno estudiado.

La orientación epistemológica es hermenéutica, ya que busca interpretar los sentidos que los participantes otorgan al proceso de atención y comprender cómo dichas experiencias se configuran en la práctica. Asimismo, se incorporan elementos

etnográficos, que facilitan la observación del entorno institucional y las interacciones cotidianas dentro del centro.

Diseño metodológico

El estudio adopta un diseño etnográfico. Este diseño permite explorar el proceso de atención desde la vida diaria del centro, atendiendo la forma en que los actores interactúan, los flujos de atención, la organización del espacio, y las dinámicas profesionales que influyen en la experiencia del usuario.

El diseño etnográfico es pertinente porque permite comprender tanto el discurso como la práctica, ofreciendo una mirada situada del proceso de ingreso y diagnóstico.

Técnicas de recolección de datos

Entrevistas abiertas a estudiantes (usuarios del CSMCU)

Se realizarán entrevistas abiertas a estudiantes que hayan recibido atención en el centro. Las entrevistas abiertas permiten que los participantes narren libremente su experiencia, sin una estructura rígida que limite el discurso.

La pregunta orientadora será:

“¿Cómo fue tu experiencia al acudir al Centro de Salud Mental y pasar por el proceso de ingreso y diagnóstico?”

Cuando sea necesario, se utilizarán preguntas espontáneas solo para profundizar aspectos relevantes como accesibilidad, trato, claridad de la información, tiempos de espera o barreras percibidas.

Entrevistas abiertas al personal de salud del CSMCU

Se entrevistará de manera abierta a miembros del personal del centro (psicología, psiquiatría y trabajo social)

La pregunta orientadora será:

“¿Cómo vive usted el proceso de atención a los estudiantes en la etapa de ingreso y diagnóstico dentro del CSMCU?”

Estas entrevistas permitirán comprender los desafíos institucionales, recursos disponibles, limitaciones, experiencias profesionales y percepciones sobre el proceso y los usuarios.

Observación participante

La observación participante se desarrollará en los espacios comunes de atención, respetando los límites éticos y de confidencialidad. Se registrará en una libreta de campo:

- Interacciones personales
- Flujos de atención
- Tiempos de espera
- Comportamientos observados
- Aspectos del ambiente físico que influyan en la experiencia

La observación permitirá contrastar lo dicho en entrevistas con lo que ocurre en la práctica cotidiana.

8.4. Triangulación de la información

La triangulación se realizará para garantizar la validez y profundidad del análisis, articulando:

1. Triangulación de fuentes

- Relatos de los estudiantes
- Relatos del personal
- Observación participante

2. Triangulación metodológica

- Entrevistas abiertas
- Observación
- Revisión normativa y documental pertinente

3. Triangulación conceptual

- Hallazgos empíricos
- Marco teórico
- Ley de Salud Mental N.º 30947
- Modelo de Atención Comunitaria
- Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030

Esta triangulación permitirá identificar patrones, divergencias y puntos de encuentro entre actores, métodos y conceptos.

Análisis de datos (ATLAS.ti)

El análisis cualitativo se realizará mediante codificación temática y hermenéutica utilizando el software ATLAS.ti, lo cual permite organizar, segmentar y relacionar la información de manera sistemática y transparente.

Procedimiento de análisis:

1. **Transcripción literal** de todas las entrevistas.
2. **Carga del material** (entrevistas y notas de campo) en ATLAS.ti.
3. **Codificación abierta:** identificación de unidades de significado.
4. **Codificación axial:** agrupación de códigos en categorías analíticas (accesibilidad, trato, barreras, procesos institucionales, etc.).
5. **Interpretación hermenéutica** articulada con el marco teórico-normativo y con la evidencia emergente.

Consideraciones éticas

La investigación garantizará:

- Consentimiento informado
- Anonimato y confidencialidad
- Voluntariedad de participación
- Protección de datos sensibles
- Respeto a la integridad de los participantes

Las entrevistas serán realizadas únicamente con autorización explícita de los participantes, resguardando su identidad y bienestar emocional.

IX. Universo y población de estudio

El universo de esta investigación está conformado por los actores directamente involucrados en el proceso de atención del Centro de Salud Mental Comunitario Universitario San Marcos (CSMCU). Para este estudio, se entiende por *actores* a todas aquellas personas que participan activamente en el proceso de ingreso y diagnóstico, ya sea brindando el servicio o recibiéndolo. Estos actores se clasifican en dos grupos principales:

Personal del centro de salud

Se refiere a los profesionales y trabajadores que participan de manera directa en la recepción, evaluación inicial, admisión, diagnóstico y orientación del usuario. Dentro de este grupo se incluyen:

- **Psicólogos/as**, responsables de la evaluación clínica inicial, consejería y seguimiento terapéutico.
- **Psiquiatras**, encargados del diagnóstico especializado, evaluación de riesgo y manejo farmacológico.
- **Trabajo social**, responsable de la evaluación sociofamiliar, derivaciones y soporte psicosocial.

Estos actores son fundamentales porque operan directamente el proceso institucional que se busca analizar.

Estudiantes universitarios usuarios del CSMCU

Se refiere a estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que han acudido al CSMCU para solicitar atención en salud mental y que han atravesado el proceso de ingreso y diagnóstico. Estos actores aportan la **experiencia vivida** del servicio, elemento central para comprender:

- accesibilidad,
- percepción de calidad,
- barreras,
- expectativas,
- y la manera en que interpretan su paso por el centro.

Los estudiantes que no han utilizado el servicio no forman parte del estudio, porque no poseen experiencia directa del fenómeno analizado.

Muestreo

Se utilizará un muestreo intencional o por criterios, tal como plantea Sampieri, seleccionando a los participantes por su relevancia y su experiencia directa en el fenómeno de estudio. Dado el carácter sensible del tema y la naturaleza cualitativa de la investigación, se entrevistará a:

- Hasta 10 estudiantes usuarios,
- Y 3 miembros del personal del CSMCU.

El criterio responde a la necesidad de obtener narrativas profundas, no representatividad estadística. La recolección concluirá cuando se alcance saturación temática, es decir, cuando los nuevos testimonios ya no aporten información novedosa.

X. Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión

1. Estudiantes de la UNMSM que hayan vivido personalmente el proceso de ingreso y diagnóstico en el CSMCU.
2. Haber recibido atención en el CSMCU dentro de los últimos 12 meses.
3. Participantes mayores de edad capaces de otorgar su consentimiento.
4. Aceptación voluntaria de participación, sin presión ni obligación.
5. Personal del CSMCU directamente involucrado en el proceso de ingreso o diagnóstico, específicamente:
 - Psicología
 - Psiquiatría
 - Trabajo social

Criterios de exclusión

1. Estudiantes que no hayan utilizado los servicios del CSMCU, debido a la ausencia de experiencia directa.
2. Usuarios que se encuentren atravesando una crisis emocional o clínica aguda, para resguardar su bienestar.
3. Personal que no participe del proceso de ingreso o primera atención (por ejemplo, personal de mantenimiento o áreas administrativas generales).
4. Personas que no otorguen consentimiento informado o manifiesten incomodidad durante la entrevista.

XI. Cronograma

areas/Fechas	oct 2024	nov 2024	dic 2024	ene 2025	feb 2025	Mar...Ago 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dic 2025	Ene 2026	Feb 2026
Revisión bibliográfica	X	x	x	x								
Diseño del cuestionario			x	x	X							
Gestión de permisos para el campo						x						
Entrevistas abiertas al personal y usuarios										x		
Observación participante										X		
Análisis de datos										X	x	
Elaboración del informe											x	
Revisión final y ajustes												x

XII. Bibliografía

Abramovich, V. (2006). *Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo*. Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Agudelo, C. A. (1983). Participación comunitaria en salud: Conceptos y criterios de valoración. *Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana*, 95(3).

Arrieta Vergara, K. M., Díaz Cárdenas, S., & González Martínez, F. (2014). Síntomas de depresión y ansiedad en jóvenes universitarios: prevalencia y factores relacionados. *Revista Clínica de Medicina de Familia*, 7(1), 14–22. <https://doi.org/10.4321/S1699-695X2014000100003>

Auerbach, R. P., Mortier, P., Bruffaerts, R., Alonso, J., Benjet, C., Cuijpers, P., ... & Kessler, R. C. (2018). WHO World Mental Health Surveys International College Student Project: Prevalence and distribution of mental disorders. *Journal of Abnormal Psychology*, 127(7), 623–638. <https://doi.org/10.1037/abn0000362>

Bowling, A. (1991). *Measuring health: A review of quality of life measurement scales*. Open University Press.

Carballeda, A. (2016). El enfoque de derechos, los derechos sociales y la intervención del Trabajo Social. *Revista Margen*, 82(1), 1–4.

Cárcamo Guzmán, K., Cofré Lira, I., Flores Oyarzo, G., Lagos Arriagada, D., Oñate Vidal, N., & Grandón Fernández, P. (2019). Atención en salud mental de las personas con diagnóstico psiquiátrico grave y su recuperación. *Psicoperspectivas*, 18(2), 59–69. <https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol18-issue2-fulltext-1582>

Cruz, F., & Aguilar, M. J. (2002). *Introducción a la psicología comunitaria*. Editorial CCS.

Cusihuaman-Lope, N., Vilela-Estrada, A. L., Cavero, V., Villarreal-Zegarra, D., & Diez-Canseco, F. (2023). Experiencias de usuarios y familiares sobre la atención recibida en

centros de salud mental comunitaria de Lima y Callao durante la pandemia de la COVID-19. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 40(3), 278–286. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2023.403.12717>

Defensoría del Pueblo. (2018). *El derecho a la salud mental: Supervisión de la implementación de la política pública de atención comunitaria y el camino a la desinstitucionalización (Informe Defensorial N° 180)*. Lima, Perú.

Del Cueto, A. M. (2014). *La salud mental comunitaria: Vivir, pensar, desear*. Fondo de Cultura Económica.

Donabedian, A. (1984). *La calidad de la atención médica*. La Prensa Médica Mexicana.

Durkheim, E. (1893). *The division of labor in society*. Free Press.

Fachado Menéndez, I., & González, E. (2013). Apoyo social y salud mental: Avances y desafíos. *Revista Cubana de Salud Pública*, 39(4), 1–15.

Goffman, E. (2004). *Internados: Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales*. Siglo Veintiuno.

Grondin, J. (2014). *A la escucha del sentido: Conversaciones con Marc-Antoine Vallée*. Herder Editorial.

Henckell Sime, C. L. del C. (2022). Incorporación del enfoque intercultural al sistema de atención de salud. *Saber Servir: Revista de la Escuela Nacional de Administración Pública*, 7, 153–171. <https://doi.org/10.54774/ss.2022.07.08>

Minoletti Scaramelli, A., Toro Devia, O., Alvarado Muñoz, R., & Rayo, X. (2015). Diferencias en percepciones de calidad de atención y respeto de derechos en salud mental entre usuarios, familiares y funcionarios. *Repositorio Universidad de Chile*. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/138077>

Ministerio de Salud. (2016). *Salud mental comunitaria: Nuevo modelo de atención*. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/342540/Salud_mental_comunitaria_Nuevo_modelo_de_atenci%C3%B3n20190716-19467-b1nnye.pdf?v=1563314461

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2003). *The World Health Report 2003: Shaping the future*. WHO.

Molina, Y. (2000). *Planificación participativa para proyectos de manejo de cuencas al nivel local: Guía de estudio*. Mérida.

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2024). Autocuidado para la salud y el bienestar. Recuperado de <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/self-care-for-health-and-well-being>

(2022). *Mental health and substance use*. Recuperado de <https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use>

(n.d.). *Quality health services*. Recuperado el 5 de diciembre de 2024, de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/quality-health-services>

Rango, G. L., & Vega, Y. (2015). Modelo de atención centrado en el paciente en Colombia: La necesidad de un salto desde lo disciplinar hacia lo organizacional. *Revista Salud, Historia y Sanidad*, 10(1), 71–83. Disponible en <http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/shs>

Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. (2021). Teleconsultas y telemonitoreo en el contexto de la pandemia: Limitaciones y desafíos. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 38(3), 1–10.

Saavedra, J. E., & Uchofen-Herrera, V. (2016). Percepciones sobre la atención de salud en personas con problemas autoidentificados de salud mental en zonas rurales del Perú. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 33(4), 785–793. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2016.334.2566>

Sanabria Ramos, Giselda. (2004). Participación social en el campo de la salud. *Revista Cubana de Salud Pública*, 30(3). Recuperado en 17 de noviembre de 2024, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662004000300005&lng=es&tlng=es

Schensul, J. J., & LeCompte, M. D. (1999). *Designing & conducting ethnographic research*. AltaMira Press.

Storm, M., & Edwards, A. (2013). Models of user involvement in the mental health context: Intentions and implementation challenges. *The Psychiatric Quarterly*, 84(3), 313–327. <https://doi.org/10.1007/s11126-012-9247-x>

Sulca, R. (2016). Evaluación de la estrategia sanitaria nacional de salud mental y cultura de paz en el distrito de Carmen de La Legua Reynoso de la provincia constitucional del Callao (Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Posgrado). <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/1424>

Thoits, P. A. (1982). Conceptual, methodological, and theoretical problems in studying social support as a buffer against life stress. *Journal of Health and Social Behavior*, 23(2), 145–159.

Villa-Palomino, J., Shimabukuro Higa, A., & Cornejo Rossello, G. (2024). Después del manicomio. *Anthropologica*, 42(52), 114–142. <https://doi.org/10.18800/anthropologica.202401.005>

ANEXOS

Anexo 01: Consentimiento informado

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS PARA PARTICIPANTES

Estimado/a participante,

Le pedimos su apoyo en la realización de una investigación conducida por Pedro Medina Gonzales, estudiante de la Maestría en Política Social con Mención en Gestión de Proyectos Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asesorada por la Dra. Mercedes Patricia Giesecke Sara Lafosse. La investigación, denominada **Percepción de los usuarios sobre la atención comunitaria en la etapa de ingreso y diagnóstico en el Centro de Salud Mental Comunitario Universitario San Marco. Periodo 2025**”, tiene como propósito Identificar y describir el cuidado integral de la salud mental de los usuarios universitarios del CSMCU San Marcos de la UNMSM.

Este estudio tiene un enfoque cualitativo y consiste en la realización de **entrevistas abiertas** orientadas a recoger experiencias, percepciones y opiniones de los actores involucrados.. La información obtenida será únicamente utilizada para la elaboración de una tesis. A fin de poder registrar apropiadamente la información, se solicita su autorización para grabar la conversación. La grabación y las notas de las entrevistas serán almacenadas únicamente por el investigador en su computadora personal protegida mediante contraseña por un periodo de tres años, luego de haber publicado la investigación, y solamente él y su asesor/asesora tendrán acceso a la misma. Al finalizar este periodo, la información será borrada.

Su participación en la investigación es completamente voluntaria. Usted puede interrumpir la misma en cualquier momento, sin que ello genere ningún perjuicio. Además, si tuviera alguna consulta sobre la investigación, puede formularla cuando lo estime conveniente, a fin de clarificarla oportunamente.

Yo, _____, doy mi consentimiento para participar en el estudio y sea realicé la grabación de la misma.

Finalmente, entiendo que recibiré una copia de este protocolo de consentimiento informado.

Nombre completo del (de la) participante Firma Fecha

Nombre del Investigador responsable Firma Fecha

Anexo 02: Entrevista abierta

GUÍA DE ENTREVISTAS ABIERTAS – CSMCU SAN MARCOS

(Para estudiantes usuarios y personal de salud)

I. ENTREVISTA ABIERTA PARA ESTUDIANTES USUARIOS DEL CSMCU SAN MARCOS

1. Presentación e indicaciones iniciales

Gracias por aceptar participar en esta entrevista. Tu participación es voluntaria y completamente confidencial. El propósito es comprender tu experiencia al acudir al Centro de Salud Mental Comunitario Universitario San Marcos (CSMCU), especialmente en la etapa de ingreso y diagnóstico. No hay respuestas correctas o incorrectas.

2. Pregunta amplia inicial (apertura narrativa)

- “Cuéntame, en tus propias palabras, cómo fue para ti la experiencia de acudir por primera vez al CSMCU.”

3. Exploración libre (invitaciones para profundizar)

- “¿Cómo viviste ese momento?”
- “¿Qué pasó después?”
- “¿Cómo te sentiste en esa parte del proceso?”
- “¿Qué significó para ti esa experiencia?”
- “Cuéntame un poco más sobre eso.”

4. Temas guía para profundizar

A. Experiencia del ingreso

- Cómo se sintió al llegar.
- Qué entendió del proceso.
- Cómo fue el primer contacto con el personal.

B. Barreras percibidas

- Dificultades para pedir cita.
- Problemas con tiempos de espera.
- Información insuficiente o confusa.
- Trato recibido.

C. Expectativas del servicio

- Qué esperaba que ocurriera.
- Qué esperaba de los profesionales.
- Qué esperaba del proceso diagnóstico.

D. Percepción general del proceso

- Qué funcionó bien.
- Qué no funcionó.
- Qué cree que debería mejorar.

5. Cierre

- “¿Hay algo más que consideres importante y que no hayamos mencionado?”

II. ENTREVISTA ABIERTA PARA PERSONAL DE SALUD DEL CSMCU SAN MARCOS

1. Presentación e indicaciones iniciales

Gracias por participar. El objetivo de esta entrevista es comprender su experiencia como profesional en la etapa de ingreso y diagnóstico de estudiantes del CSMCU San Marcos. Sus respuestas serán confidenciales.

2. Pregunta amplia inicial (apertura narrativa)

- “Cuénteme cómo es para usted el proceso de ingreso y diagnóstico de los estudiantes en el CSMCU.”

3. Exploración libre (invitaciones para ampliar)

El entrevistador puede usar expresiones como:

- “¿Y cómo suele desarrollarse ese proceso?”
- “¿Qué ocurre normalmente en un día típico?”
- “Cuénteme más sobre esa parte.
- “¿Cómo se siente usted en ese momento del proceso?”

4. Temas guía para profundizar

A. Condiciones institucionales

- Recursos humanos disponibles.
- Recursos materiales o logísticos.
- Infraestructura.

B. Condiciones operativas

- Carga laboral.
- Organización interna.
- Flujo de atención.
- Demandas versus capacidad real.

C. Necesidades de los estudiantes

- Qué suelen requerir o solicitar.
- Patrones o situaciones frecuentes.
- Dificultades comunes.

D. Articulación con otros servicios

- Trabajo con otras áreas o instituciones.
- Derivaciones.
- Soporte institucional.

E. Experiencia profesional

- Qué facilita su labor.
- Qué la dificulta.
- Qué cambiaría si fuera posible.

5. Cierre

- “¿Hay algo más que considere importante añadir sobre su experiencia en este proceso?”

Anexo 03: guía de Observación Participante

GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DE SALUD MENTAL UNIVERSITARIO EN EL CSMCU SAN MARCOS

- **Propósito:** Identificar el flujo de atención de los usuarios desde que llegan al CSMCU San Marcos hasta que se retiran.
 - **Número de observaciones:** Se estiman unas 10 sesiones en el transcurso de un mes
 - Anotar por escrito las ocurrencias durante el flujo de atención y el servicio brindado.
- **Procesamiento:** Entrega del formato de registro de la observación en formato Word, así como de las fotos tomadas.

A. Pautas básicas de registro y vaciado de información

- Registrar sistemáticamente el tiempo cada 10 minutos. Adicionalmente, es preciso registrar el tiempo de inicio y fin de cada actividad.
- Describir TODO lo que ocurre en el CSMCU durante la jornada laboral, enfatizando la mirada en los puntos que se detallan a continuación:
- Características del espacio donde se realiza la sesión y la atención: Infraestructura, mobiliario y equipamiento de los consultorios u otro espacio donde se realice la sesión.
- Materiales: Dotación y uso de materiales
- Clima durante el servicio de atención: Acciones orientación, vínculo entre pares y entre el personal del centro y el usuario.
- La narración debe ser clara y detallada. Es indispensable DESCRIBIR, no juzgar.
- Además del registro escrito, se tomarán algunas fotografías en momentos clave de la jornada
- Registrar separadamente las impresiones o interpretaciones del observador respecto de lo que está ocurriendo en el establecimiento.

B. Protocolo de observación: Se debe prestar atención a los siguientes aspectos durante la observación y considerarlos al momento de completar el formato de registro.

1. **El escenario de la observación:** Mobiliario, equipamiento y enseres.
 - Características del espacio donde se realiza la atención al usuario

- Características del espacio: tamaño, ventilación, iluminación, ruido, temperatura, limpieza, orden, estado de ventanas, paredes y pisos.
 - Descripción del mobiliario: mesas (tipo: unipersonales, bipersonales, estado de conservación, disposición en el consultorio en filas o grupos), pizarras (número, tipo: acrílica o para tiza, estado de conservación, ubicación en el consultorio), muebles para almacenamiento de materiales, computadoras, otros
- Actores:
 - El personal: describir a grandes rasgos su actitud durante la atención.
 - Los usuarios: número de hombres y de mujeres, actitud durante la atención.
 - Disposición de los actores: cómo están distribuidos los actores en el espacio.
2. **Desarrollo de la sesión:** esta es la parte principal de la observación. Queremos conocer en detalle cómo se realizan las actividades de las atenciones, el flujo de los usuarios dentro del CSMCU
- Secuencia de actividades:
 - ¿Cómo se inicia la atención?
 - ¿Cómo se brinda información?
 - ¿Cuánto se demora en ser atendido el usuario?
 - ¿Cómo es la entrega de medicina?
 - ¿Cuánto tiempo demora la entrega de medicina?
 - ¿Cómo se programa una próxima cita?
 - ¿Cuánto tiempo hay que esperar para la próxima cita?
3. **Clima de la sesión:** nos interesa registrar el ambiente en el que transcurre el proceso de atención
- ¿Cómo son las relaciones entre el personal y el usuario? ¿Cuántas personas del personal entablan una dinámica con el usuario durante su visita?
 - ¿Cómo se relacionan los usuarios entre sí?
 - ¿Cómo es la interacción del usuario con su entorno físico?
 - ¿Cómo se relacionan el personal entre sí?
4. **Uso del tiempo:** nos interesa registrar el tiempo que requiere el flujo para brindar atención al usuario del CSMCU, así como mantener un registro sistemático cada 10 minutos. También queremos saber a qué tipo de actividades dedica más tiempo el personal
- ¿Qué actividades toman más tiempo durante todo el flujo de atención?
 - ¿Qué interrupciones hay durante el servicio de atención? ¿Cómo maneja el personal dichas interrupciones?
 -
5. **Sobre el observador:** el observador es también parte de la observación, por lo cual es necesario considerar diversos aspectos de su presencia en el espacio de la sesión.
- ¿Cómo afecta al personal y al usuario la presencia del observador? ¿Cómo reaccionan ante su presencia?
 - ¿En qué condiciones físicas y anímicas se encuentra el/la observador/a cada día?

C. Registro de la información: El registro de la observación deberá entregarse en el siguiente formato.

FORMATO DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN

Investigador:

Región:

Provincia:

Distrito:

Nombre del Establecimiento:

Fecha de registro:

Hora de inicio:

Hora de término:

I. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA SESIÓN

- **¿Qué hay en el lugar? Detallar**

--

- **Impresiones (sobre el ambiente, cuidado, higiene, ruido, flujo de personas, etc)**

--

- **¿Qué materiales y recursos se emplean durante la atención? Listar e indicar si son suficientes y están al alcance de los usuarios. Describir donde se ubican, si son proporcionados por el personal o están a la vista.**

Guía de Observación Participante - Notas de Campo	
Descripción:	Interpretación:

Título: Percepción de los usuarios sobre la atención comunitaria en la etapa de ingreso y diagnóstico en el Centro de Salud Mental Comunitario Universitario San Marcos. Periodo 2025						
Problema: Desarrollo de la atención al usuario en la etapa de ingreso y diagnóstico de los usuarios universitarios que asisten al Centro de Salud Mental Comunitario Universitario San Marcos						
Pregunta General: ¿Cómo vivencian los estudiantes y el personal de salud del CSMCU el proceso de ingreso y diagnóstico, y qué factores influyen en su desarrollo?						
Objetivo General: Analizar el proceso de ingreso y diagnóstico en el CSMCU San Marcos desde las percepciones de estudiantes y personal de salud, identificando los factores que influyen en la experiencia de atención inicial						
Hipótesis general: Existen barreras percibidas por estudiantes y personal que afectan el proceso de ingreso y diagnóstico en el CSMCU.						
Preguntas específicas de investigación	Objetivos específicos	Hipótesis específicas	Variable	Indicador	Fuentes de verificación	Técnicas
1.¿Qué experiencias, barreras y expectativas expresan los estudiantes respecto a su proceso de ingreso y diagnóstico en el CSMCU?	1. Describir las experiencias, barreras y expectativas percibidas por los estudiantes durante el proceso de ingreso y diagnóstico en el CSMCU San Marcos.	1. Los estudiantes perciben barreras de acceso y claridad en el proceso..	1. Percepción estudiantil del proceso de atención inicial	Relatos sobre experiencias emocionales y practicas	Transcripción de Entrevista abierta	Entrevista abierta
				Barreras percibidas	Transcripción de Entrevista abierta	Entrevista abierta
					Obsercaciones Directas	Observación Participante
				Expectativa de los estudiantes	Transcripción de Entrevista abierta	Entrevista abierta
				Claridad del procedimiento	Transcripción de Entrevista abierta	Entrevista abierta
2.¿Qué limitaciones institucionales y operativas que afectan el desarrollo de la atención inicial identifica el personal de Salud?	2. Identificar las limitaciones institucionales y operativas vinculadas a la atención inicial de los estudiantes.	2.El personal identifica limitaciones institucionales y operativas.	2.1. Limitaciones institucionales y operativas	Recursos humanos	Documentos internos del CSMCU	Análisis documental
				Recursos logísticos	Personal del Centro	Entrevista abierta
				Servicios de salud mental complementarios del CSMCU	Personal del Centro	Entrevista abierta
				Carga laboral del personal	Informes de carga laboral	Análisis documental

3. ¿Qué puntos en común y qué diferencias surgen entre las percepciones de estudiantes y personal de salud sobre la calidad, accesibilidad y organización del proceso de atención inicial?	3. Comparar y triangular las percepciones de ambos actores para reconocer coincidencias, diferencias y oportunidades de mejora en el proceso de atención inicial.	3. Las percepciones de estudiantes y personal muestran diferencias significativas.	3.1. Convergencias y divergencias en percepciones sobre la atención inicial	Coincidencias entre el personal y los estudiantes usuarios	Transcripción de Entrevista abierta	Entrevista abierta
				Diferencias entre el personal y los estudiantes usuarios	Transcripción de Entrevista abierta	Entrevista abierta
				Oportunidades de mejora identificadas	Transcripción de Entrevista abierta	Entrevista abierta



UNMSM

Firmado digitalmente por DIAZ
ARRIOLA Luisa Esther FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.08.2025 19:27:46 -05:00

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú. Decana de América
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIDAD DE POSGRADO

Lima, 18 de Agosto del 2025

CARTA N° 000010-2025-UPG-VDIP-FCCSS/UNMSM

Señor

PEDRO ALEJANDRO CRUZADO PUENTE

Director General de la

Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro

Presente.

Asunto: CARTA DE PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR DE UPG - FCCSS - COD: 23157080
- DOC: 74710886 - AP. PAT.: MEDINA.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle y a la vez presentarle al Bachiller **PEDRO AUGUSTO MEDINA GONZALES**, con Código de Matrícula N° 23157080 y con DNIN° 74710886, alumno de la *Maestría en Política Social con mención en Gestión de Proyectos Sociales* la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El citado Bachiller se encuentra desarrollando la investigación de su tesis, denominada: «*Percepción de los usuarios sobre la atención comunitaria en la etapa de ingreso y diagnóstico en el Centro de Salud Mental Comunitario Universitario San Marcos. Periodo 2025*» para poder obtener el grado académico de Magister; para lo cual me permito solicitarle se le brinde las facilidades de la Institución que usted dirige, para la culminación de esta investigación de carácter académico.

Agradeciendo la atención prestada a la presente, le expreso mi más alta estima personal.

Atentamente,

Dra. LUISA ESTHER DÍAZ ARRIOLA
Directora

LV:Alhc.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú. Decana de América
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Instituto de Investigaciones Psicológicas

COMITÉ DE ÉTICA

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y
de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

**CONSTANCIA DE VIABILIDAD ÉTICA
DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN**

N° 030-CE-FP/UNMSM-2025

Luego de la evaluación de los aspectos éticos del proyecto ***“Percepción de los usuarios sobre la atención comunitaria en la etapa de ingreso y diagnóstico en el Centro de Salud Mental Comunitario Universitario San Marcos. Periodo 2025”***, presentado por el bachiller egresado de la Maestría en Política Social con mención en Gestión de Proyectos Sociales de la UNMSM, **MEDINA GONZALES, Pedro Augusto** destinado a optar el grado académico de magister, el Comité de Ética del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Facultad de Psicología- Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluyó en que el mismo, cumple con las normativas éticas correspondientes, por lo que expide la presente **CONSTANCIA de CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS ÉTICOS**.

C.U., 22 de julio de 2025



UNMSM

Firmado digitalmente por DIOSSES
CHOCANO Alejandro Segundo FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.07.2025 16:22:40 -05:00

Dr. Alejandro S. Dioses Chocano
Presidente del Comité de Ética
Instituto de Investigaciones Psicológicas
Facultad de Psicología - UNMSM

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Calle Germán Amézaga N.º 375- Lima (frente al Instituto de Medicina Tropical)
Teléfono 619-7000 Anexo. 3216-3217